

LE CANCER DU SEIN

Pr bouchikhi chahrazed

I – INTRODUCTION :

- 1er cancer de la femme.
- 1ère cause de mortalité par cancer chez la femme
- Pronostic favorable si diagnostic précoce

but

- Comment faire le diagnostic positif?
- Quelles sont les modalités thérapeutiques?
- Comment faire le dépistage et chez qui?

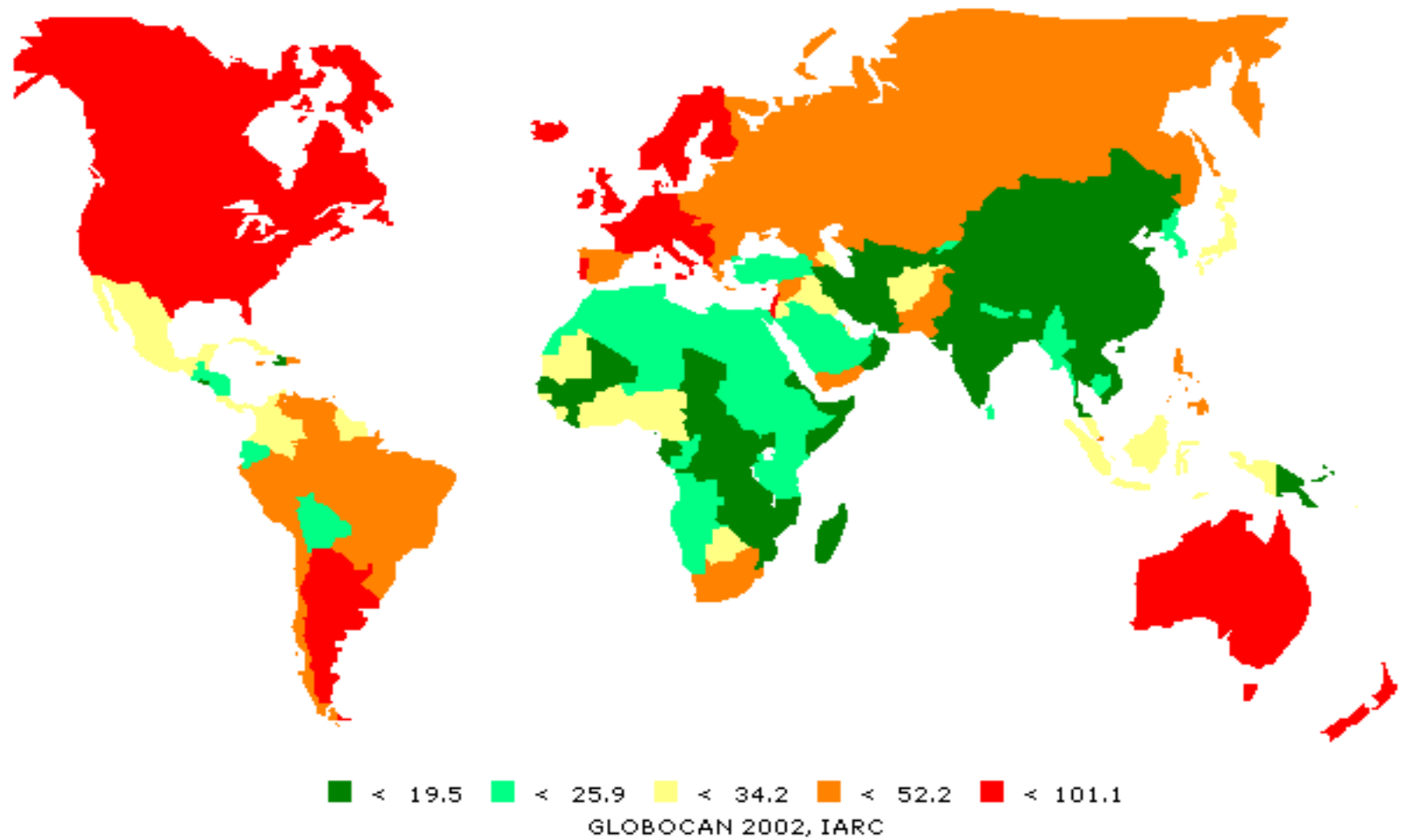
II – EPIDEMIOLOGIE :

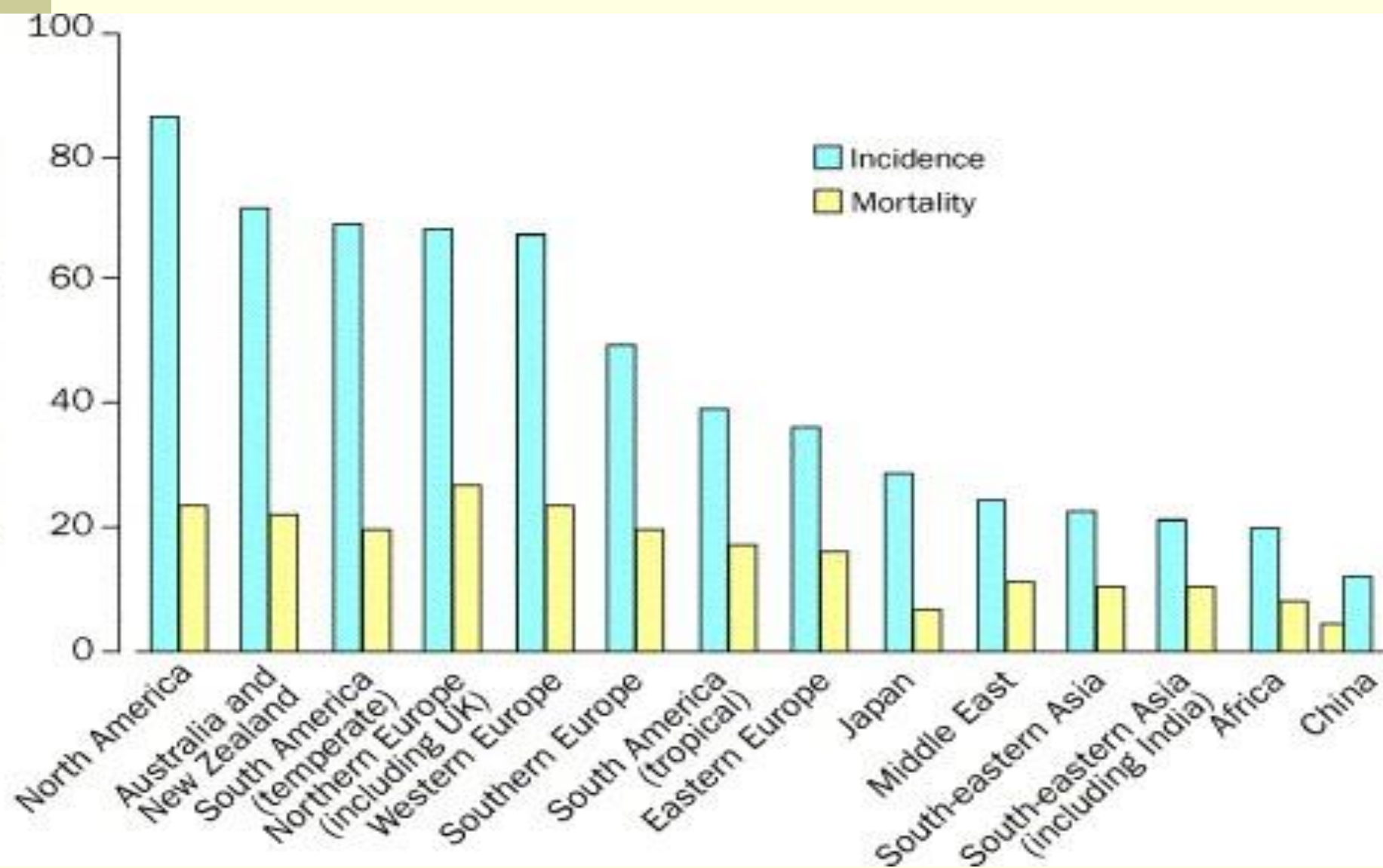
A- FRÉQUENCE

Le pus fréquent dans plus part des pays

- ❖ Dans le monde: + un million de nouveaux cas.
 - ❖ 30 % de nouveaux cancer chez la femme dans les pays développés
 - ❖ 16 % dans les pays en voie de développement MAIS ???
- ❖ 30-35% cancers de la femme

Breast
Age-Standardized incidence rate per 100,000





En France :

- * 25 000 nouveaux cas par an.
- * 10 000 décès par an :
= 1ère cause de mortalité par cancer chez la femme.

Au Maroc :

- 10000 - 12000 nouveaux cas par an.
- 38% CANCERS FEMME

B- FACTEURS DE RISQUE :

1- Facteurs génétiques :

⇒ Antécédents familiaux de cancer sein:

* Formes familiales = 5 à 8 %

* Si atteinte d'apparenté du premier degré
(mère ,sœur , fille)

* Facteurs génétiques : confirmés

- 12% mutations génétiques

- Les gènes *BRCA1* et *BRCA2* :

- 95% formes familiales cancer sein et ovaire

- 65 % formes familiales de cancer du sein seul

2 - Facteurs hormonaux :

témoignent de l'imprégnation estrogénique :

- * Ménarches précoces (avant 12 ans)
- * Ménopause tardive (après 55 ans)
- * Age de la première grossesse < 30ans tardif
- * Femmes nullipares, paucipares.
- * Femme non allaitante
- * Contraception hormonale ???
- * THS de la ménopause ???

3 - antécédents pathologiques du sein

= **LES MASTOPATHIES BENIGNES :**

- Mastopathies proliférantes avec **ATYPIES**

 - * RR 3,7 si hyperplasie atypique

- Surtout si :

 - *pré ménopause + ATCD familial cancer sein.

 - *RR 5,9 si une hyperplasie atypique en pré ménopause

 - *RR 7,3 si hyperplasie atypique + ATCD familial du cancer invasif

4- Facteurs environnementaux :

- *Obésité +++*
- *Graisses : quantité totale ++*
- *privilégier la consommation de fruits et légumes*
 - *EVITER LES ALIMENTS transformés*
 - *les antioxydants +++*
- *Café et thé : Étude suédoise: pas de risque*
- *alcool : deconseiller*
- *Irradiation*
- *Activité physique : rôle protecteur*
- *autres : +++++*



III – ANATOMIE PATHOLOGIQUE

A - Adénocarcinomes : le plus fréquent 98 % des cas

1 - Carcinomes in situ :

= Non invasifs = Non infiltrants

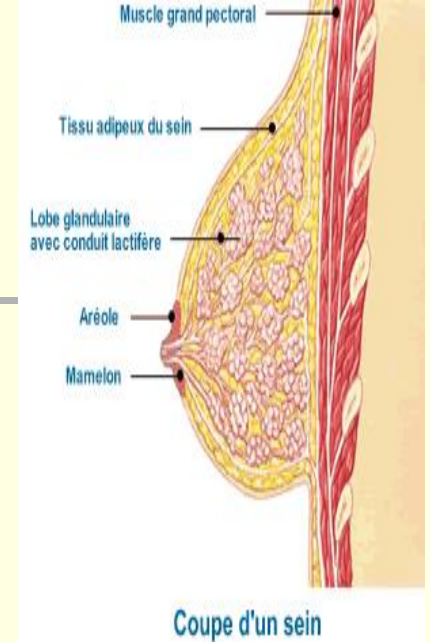
* 3 - 4 % des cancers du sein.

- Deux types :

* Carcinomes canauxiaux in situ (2 - 3 %)

= Carcinomes intra canauxiaux

* Carcinomes lobulaires in situ (1 %)



2 - Carcinomes invasifs :

- Plusieurs types :

- * Adénocarcinomes NOS
- * Adénocarcinomes lobulaires
- * La maladie de Paget
- * Carcinomes médullaires
- * Carcinomes colloïdes
- * Carcinomes tubuleux
- * Carcinomes papillairesetc.

B - Les sarcomes :

2 % des cas (= Tumeurs conjonctives) :

- * Sarcomes phyllodes.

- * Sarcomes du stroma primitif :

 - Angiosarcomes

 - Fibrosarcomes

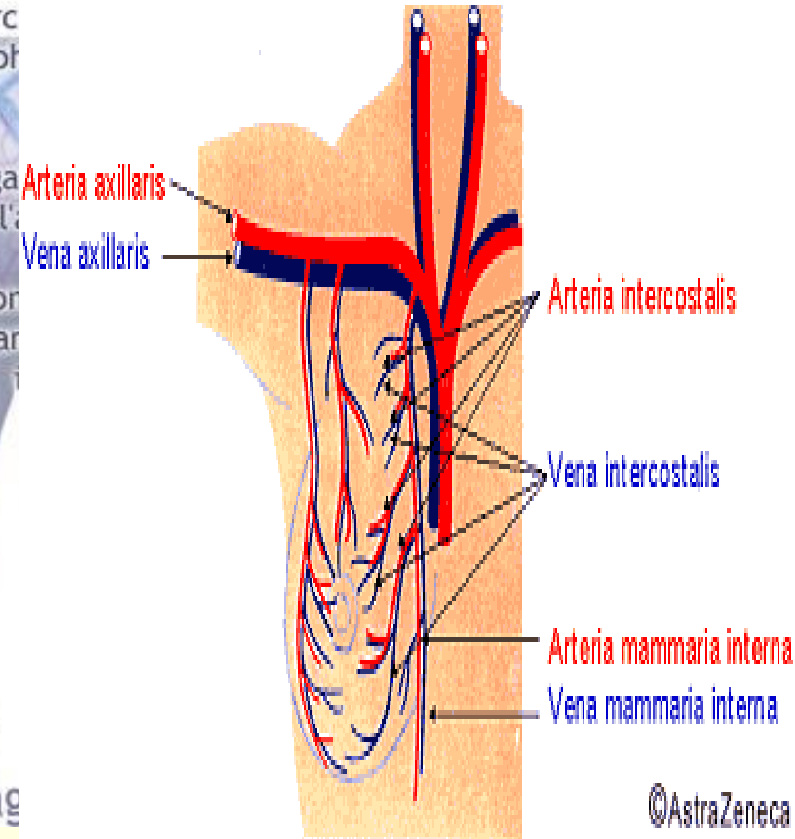
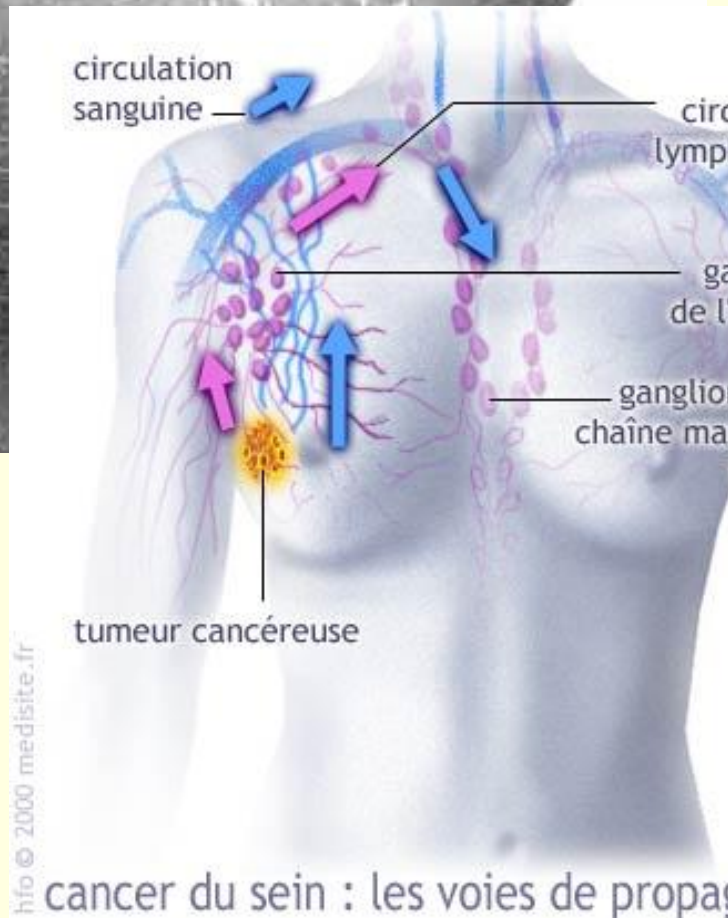
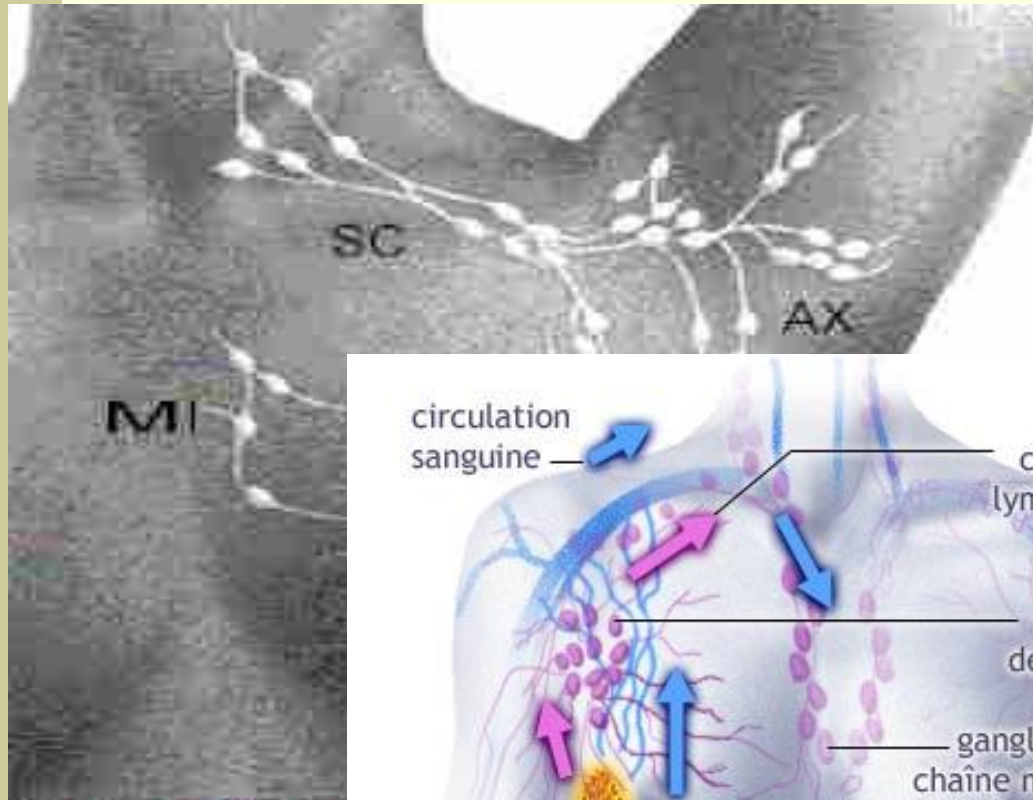
 - Liposarcomes

 - Leiomyosarcomes

 - Lymphomesetc.

C- tumeurs secondaires exceptionnelles

IV – EXTENSION :



A - Extension locale :

Dans le même sein.

Proche en proche par voie galactophorique.

B - Extension lymphatique :

- Ganglions axillaires : ++++

Extension de BAS en HAUT

Si Tumeur > 3 cm => 50% d'envahissement
Axillaire.

- Ganglions de la chaîne mammaire interne :

Quadrants INTERNES, Région CENTRALE

C - Extension hématogène :

Par voie sanguine

L'extension se fait vers :

- * L' OS ++++
- * LE POUMON +++
- * LE FOIE ++
- * LE CERVEAU +

V – DIAGNOSTIC POSITIF : +++

A – Diagnostic clinique :

circonstances de découverte

- * souvent par la patiente elle-même**
- * consultation gynécologique**
- * dépistage**

1 - Interrogatoire :

- Facteurs de risque majeurs
- Antécédents personnels et familiaux
- Mode d'installation
- L'évolution ...etc.

- Motif de consultation :

- * **Tumeur : +++ 65 – 80 % des cas.**

Date de début ☐ la vitesse de croissance tumorale

- * **Douleur : 15 % des cas**

En général, PAS DE DOULEUR ,

- * **Modifications cutanées : 5 – 7 %**

- * **Écoulement mamelonnaire : 2 – 10 %**

☐ UNILATERAL, UNIPORE , et SEROSANGLANT.

- * **Adénopathie (s) axillaire (s)**

- * **Gros bras :**

2 - Examen clinique :

Conditions de l'examen ++++

a - L'inspection :

- Modification des contours du sein
- Asymétrie des deux seins , des deux mamelons
- Signes inflammatoires :
 - * Rougeur
 - * Peau d'orange

- Modifications cutanées :

- * Rétraction, dépression**
- * Ombilication du mamelon**
- * Ulcération cutanée**
- * Aspect et coloration de la peau**

- Autres signes :

- * Lésion eczématiforme**
- * Ecchymose**
- * Circulations veineuses superficielles**
- * Adénopathies axillaires ou sus claviculaires.**

b - La palpation :

a - La tumeur :

* Siège de la tumeur : **Sein gauche** > **sein droit**

Quadrant supéro-externe : 38,5%

Retro mamelonnaire : 29%

Quadrant supéro-interne : 14,2%

* La taille de la tumeur :

=> Plus grand diamètre : en cm

Si tumeur multifocale : plus grande tumeur.

* Les limites de la tumeur :

Mal limitée .

Parfois, limites très nettes

* La consistance :

DURE ++++

MOLLE(Carcinome colloïde, médullaire)

* La mobilité :

Plan superficiel et profond.

*** La focalité :**

Multifocalité : Tumeurs même quadrant

Muticentricité : tm distants de > 5cm.

Bilatéralité : Tumeurs des deux seins

*** Signes inflammatoires :**

= TRIADE : Rougeur, Chaleur, Douleur

⇒ Tumeurs à croissance rapide

⇒ Mastite carcinomateuse

*** Sensibilité :**

Souvent la tumeur n'est pas sensible ++++

β - Mamelon : ⇒ Écoulement

20 à 40 % des cas ⇒ cancer du sein :

Uni ou bilatéral uni ou multipore

χ - Aires ganglionnaires :

- * Doit être SYSTEMATIQUE.**

- * AXILLAIRES et SUS CLAVICULAIRES
DES DEUX COTES**

- * Adénopathies suspectes si :**

**DURE, ASYMETRIQUES,
FIXEES et SENSIBLES.**









c - Examen général:

A la recherche de métastases :

Pleuro-pulmonaires

Hépatiques

Osseuses (Points osseux douloureux
++++)

B – Le diagnostic paraclinique :

I- examens radiologiques

LA MAMMOGRAPHIE

ET

L'ÉCHOGRAPHIE MAMMAIRE.

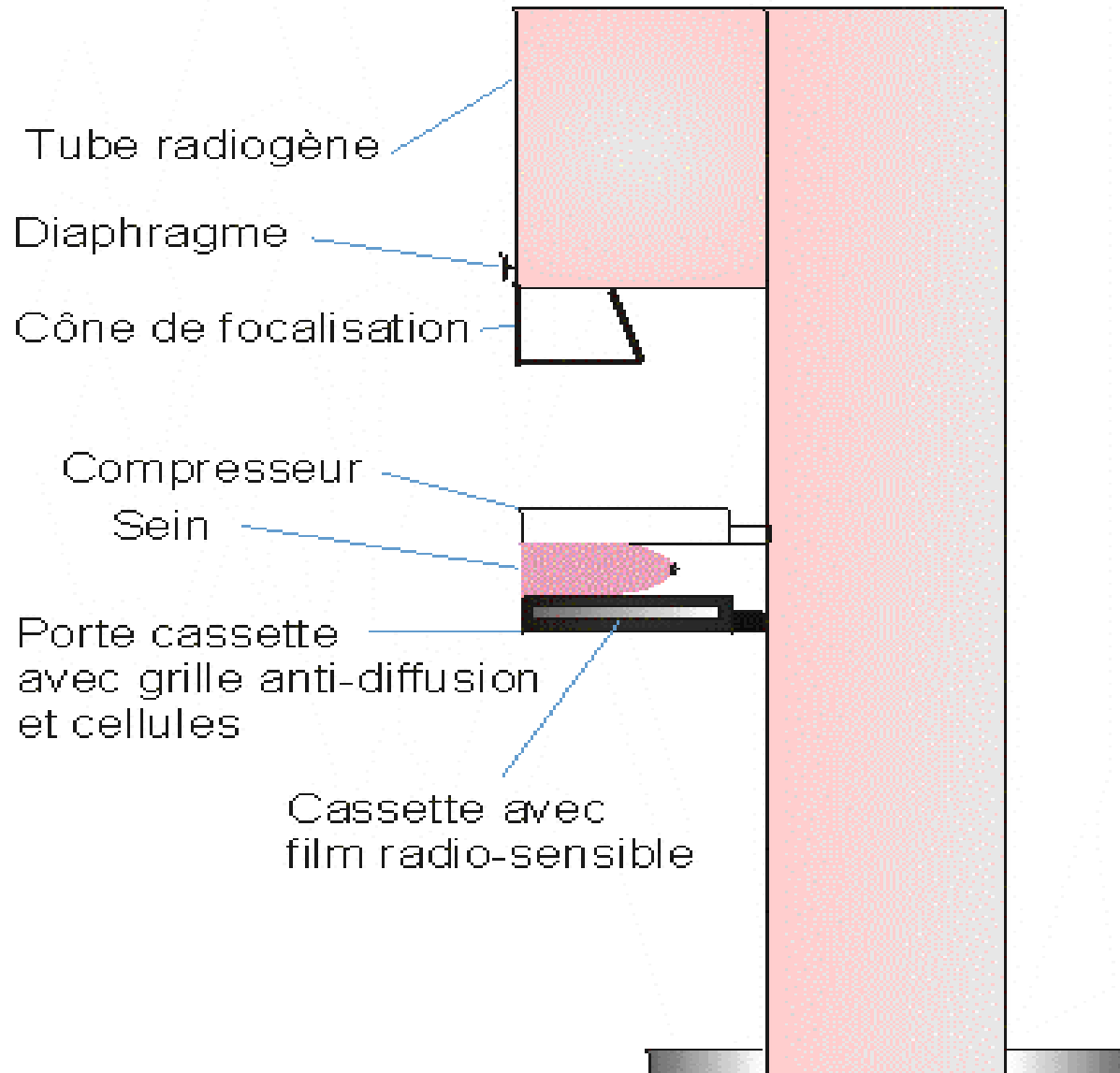
1 - La mammographie :

- * examen primordial
- * entre J8 et J10 des règles
 - peu de congestion
- * réalisé en première intension sauf
 - Femme enceinte et allaitante
 - Jeune fille (30 ans)
- * utilisé également dépistage (tumeur infracliniques)
- * Face, profil et oblique externe
 - Clichés complémentaires +/-

codification du risque de cancer selon classification ACR 0 à 5

- * ACR 0 □ nécessite autres investigations**
- * ACR 1 □ normal**
- * ACR2 □ absence de signes de malignité**
- * ACR3 □ bénin probable mais à surveiller à court terme**
- * ACR4 □ anomalie suspecte : biopsie s'impose**
- * ACR5 □ haute probabilité de malignité**

Mammographie





Incidence de



Compression centrée pl
agrandissement par aug
de la distance sein film



différentes images

■ Opacité typiquement SI MALIN

- * Stellaire,

- * Spiculée, à centre dense

- * Contours irréguliers

- * Prolongements opaques , linéaires

- * Taille < la masse palpée.

■ Microcalcifications :

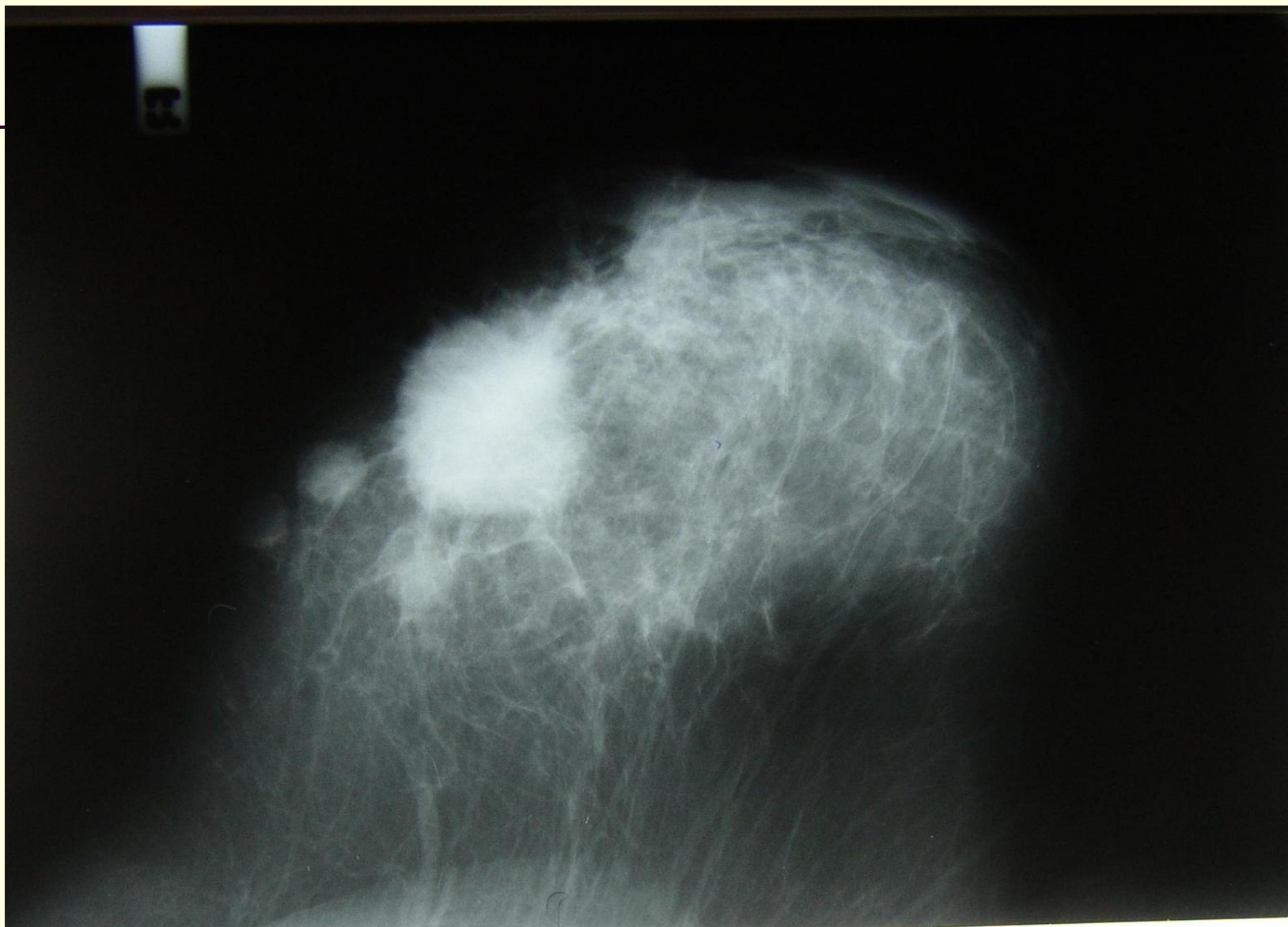
- * Isolées ou associées à l'opacité
- * microcalcifications vermiculaires
- * la forme d'un bâtonnet
- * souvent Irrégulières,
- * groupés en amas

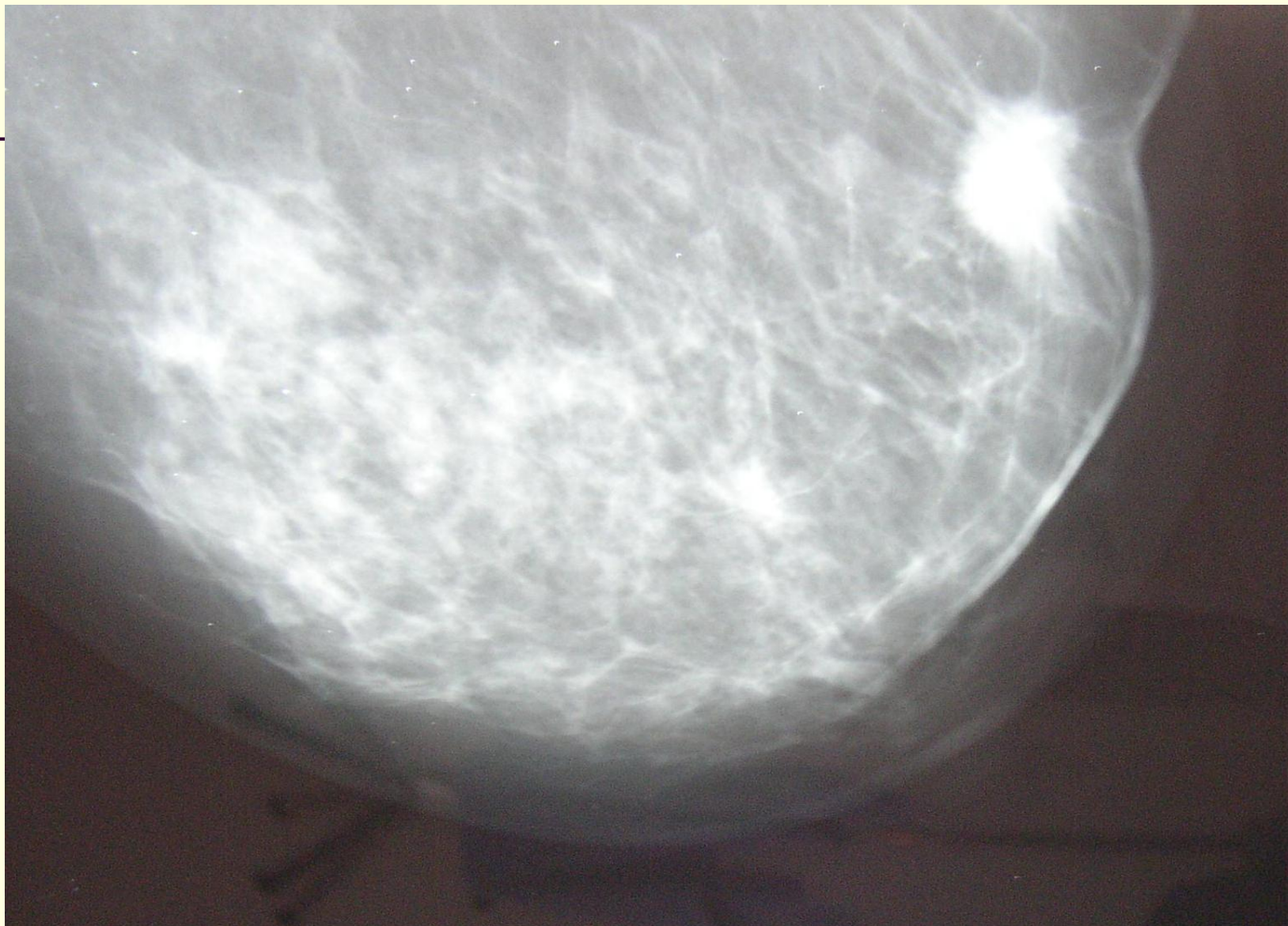
=> 30 à 50 % KC infra cliniques.

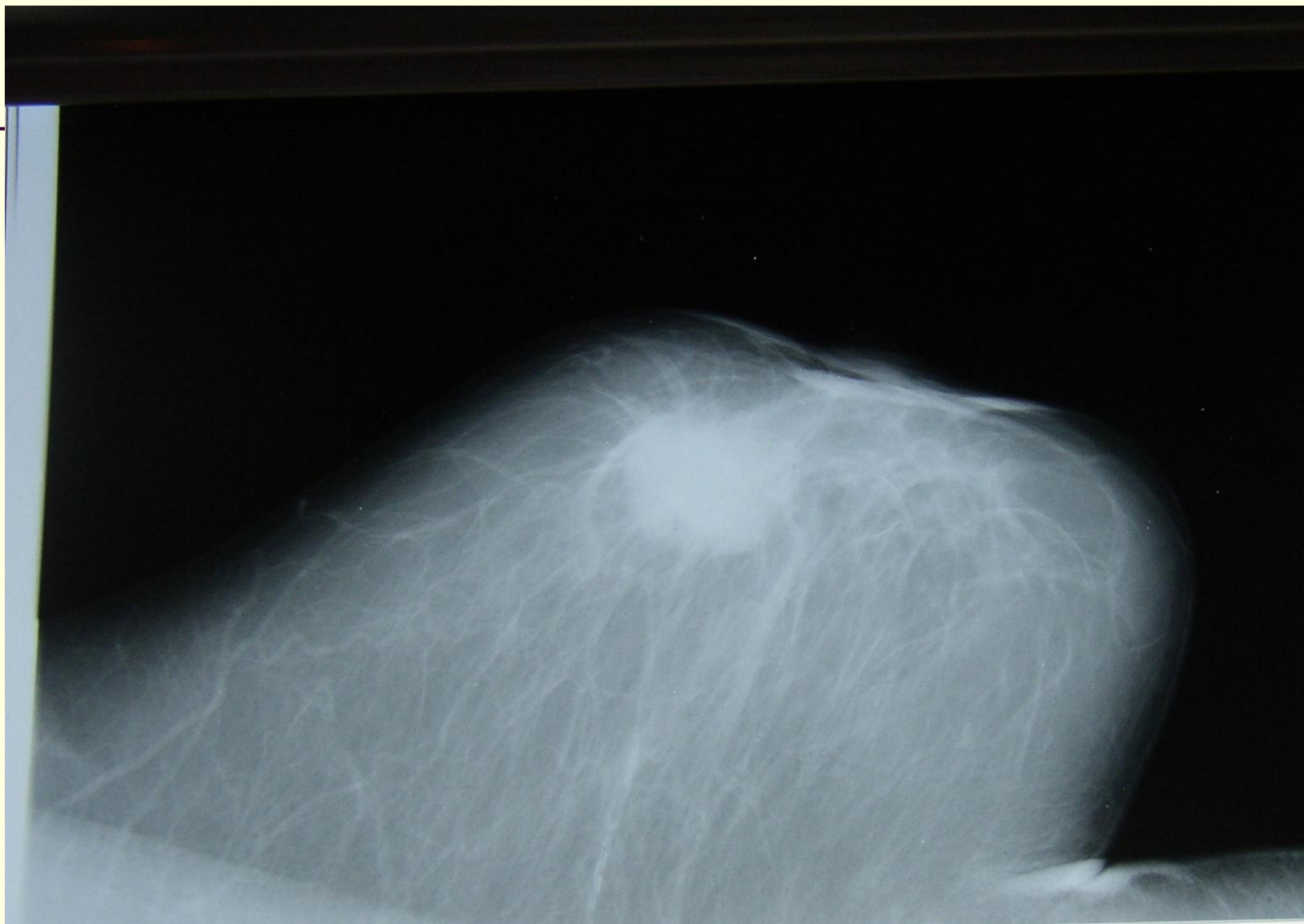
■ Autres :

- Désorganisation architecturale
- Rétraction,
- Épaississement cutané.

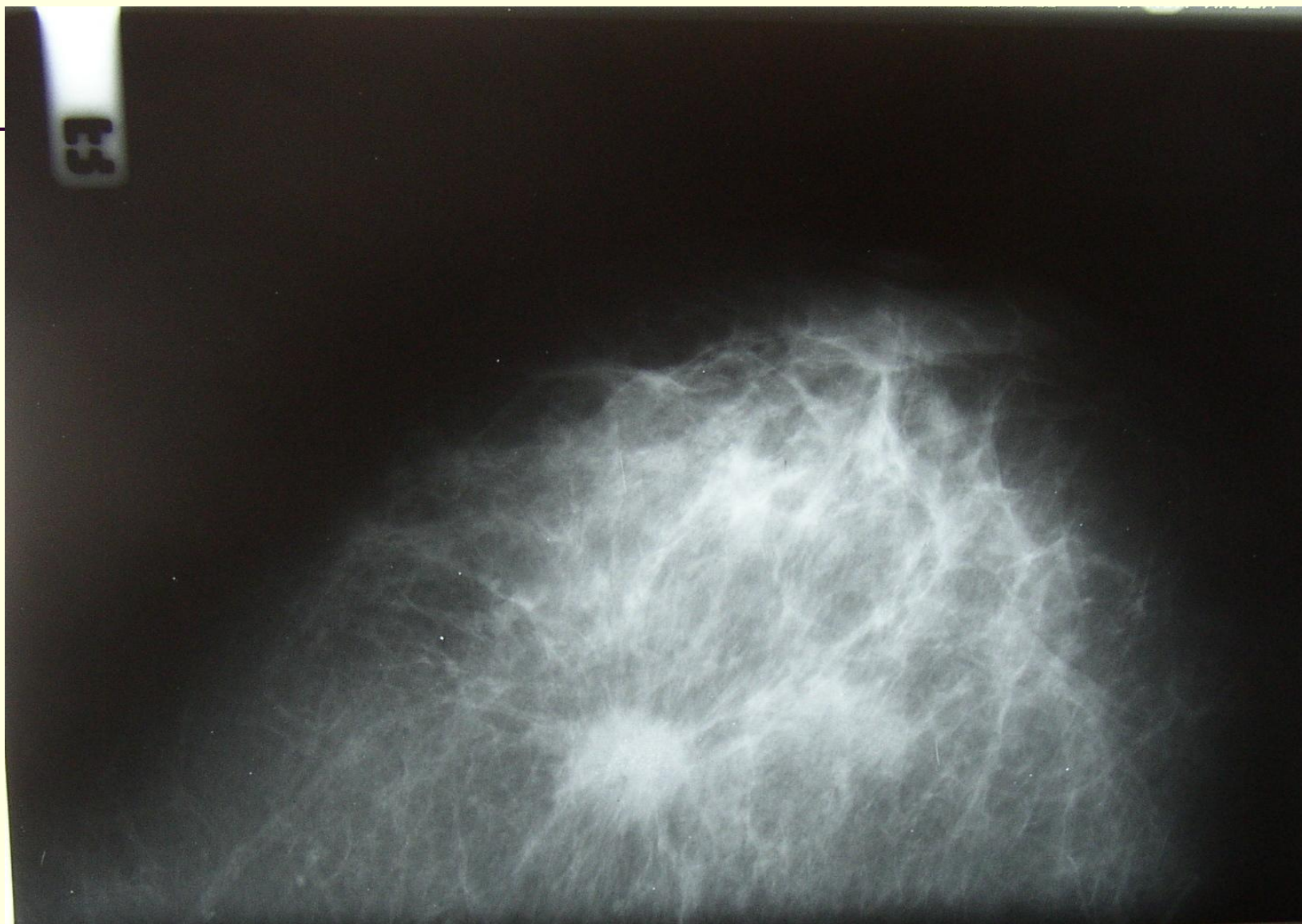
- Possibilité autres signes non typiques :
 - * Opacité ronde ,
 - * opacité microlobulée
 - * Micro calcifications poussiéreuse ou punctiformes ou encore rondes, régulières
 - * hyperdensité mal systématisée surtout à limites convexes....







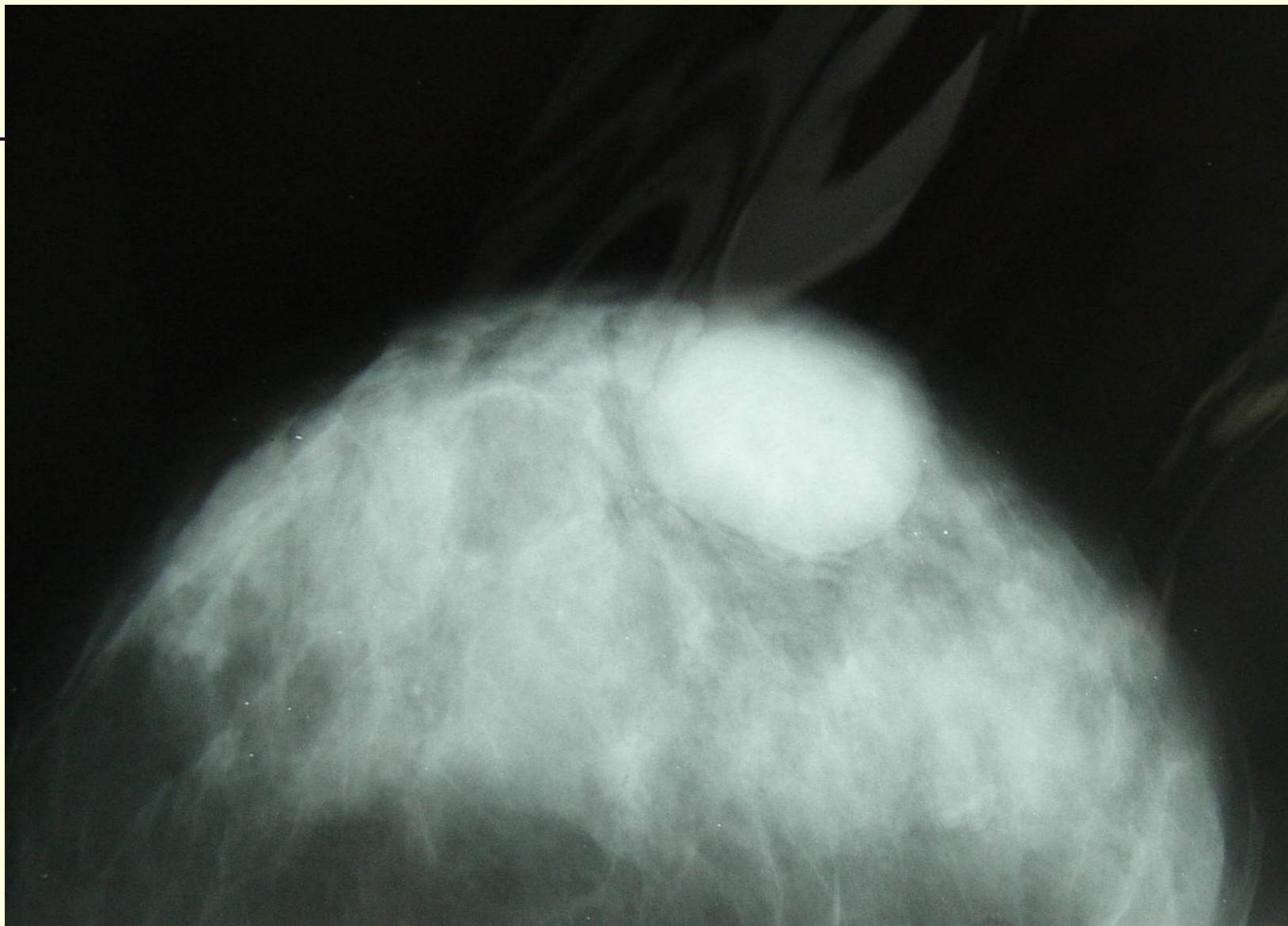
53

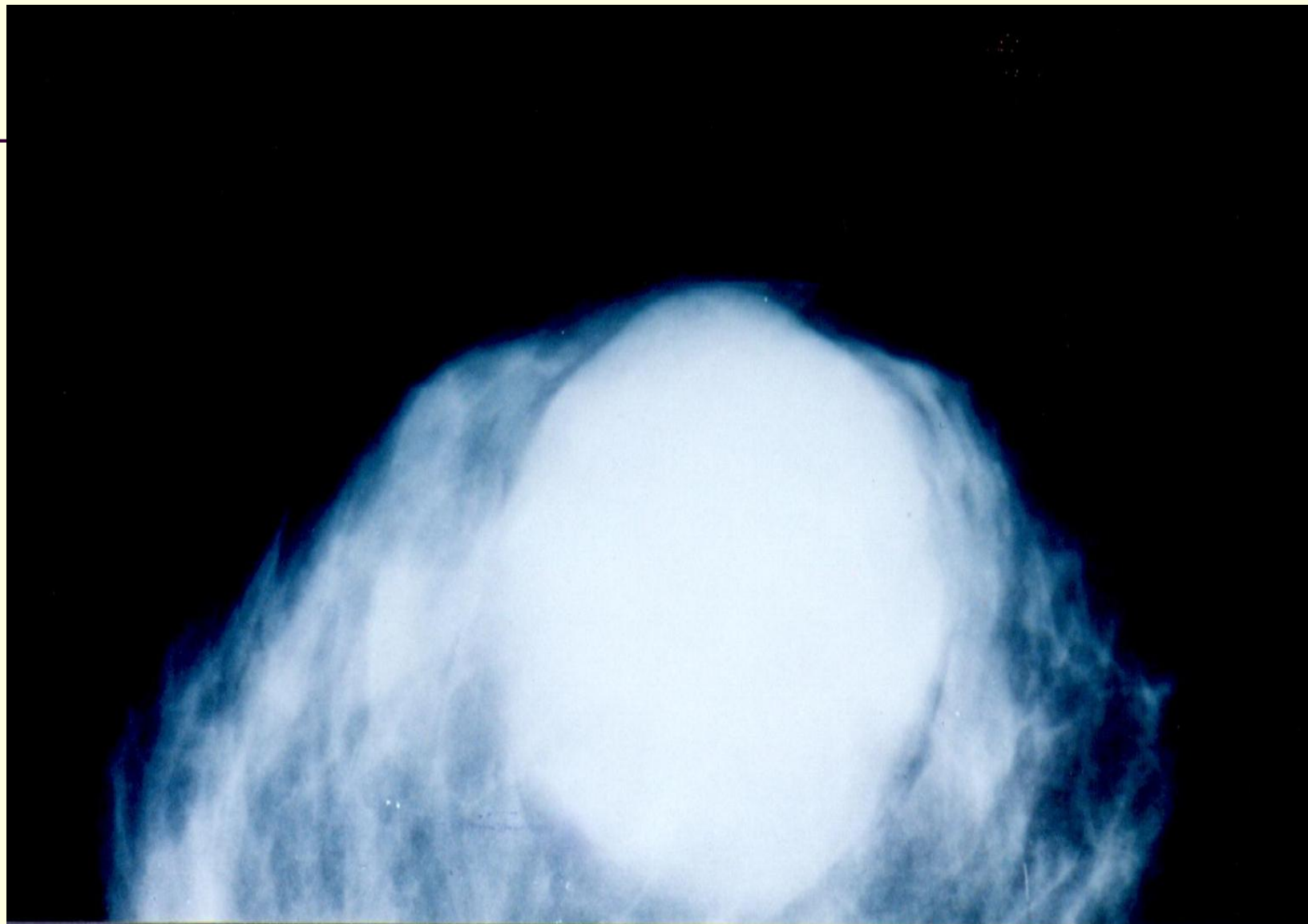


00



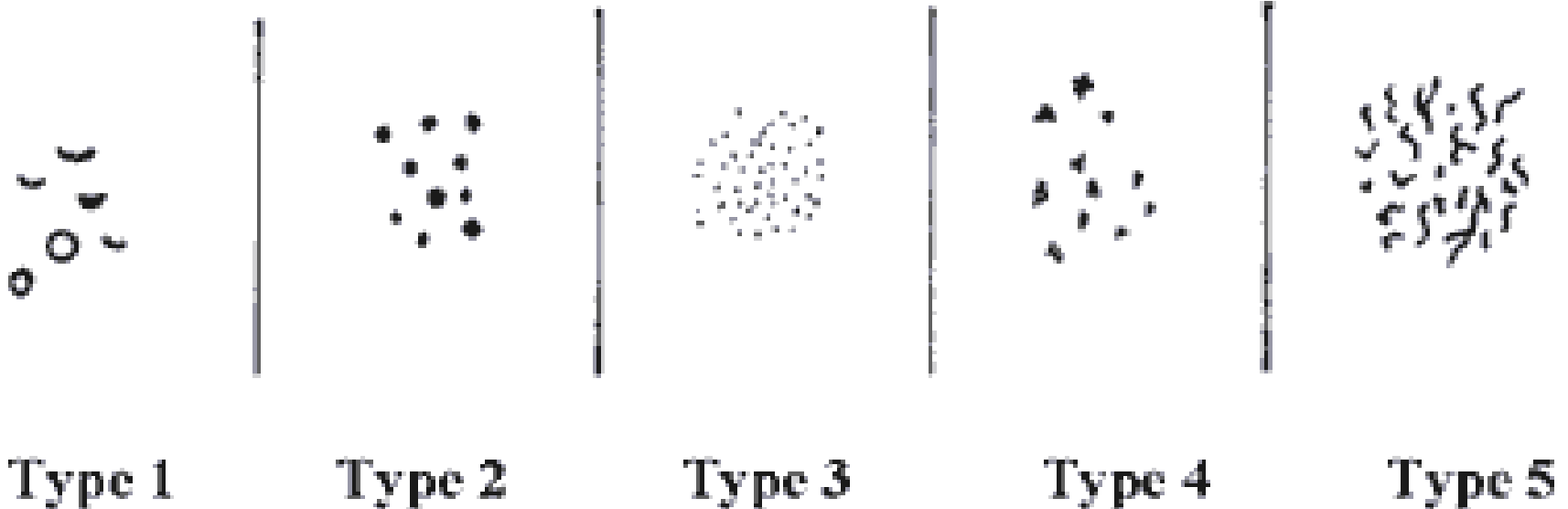






CLASSIFICATION MORPHOLOGIQUE DES MICROCALCIFICATIONS

QE!!



Type 1 : micro calcifications annulaires, arciformes ou polyédriques.

Risque de cancer du sein quasi nul.

Type 2 : micro calcifications rondes et de tailles variables.

Risque de carcinome évalué à 22 %.

Type 3 : micro calcifications poussiéreuses pulvérulentes.

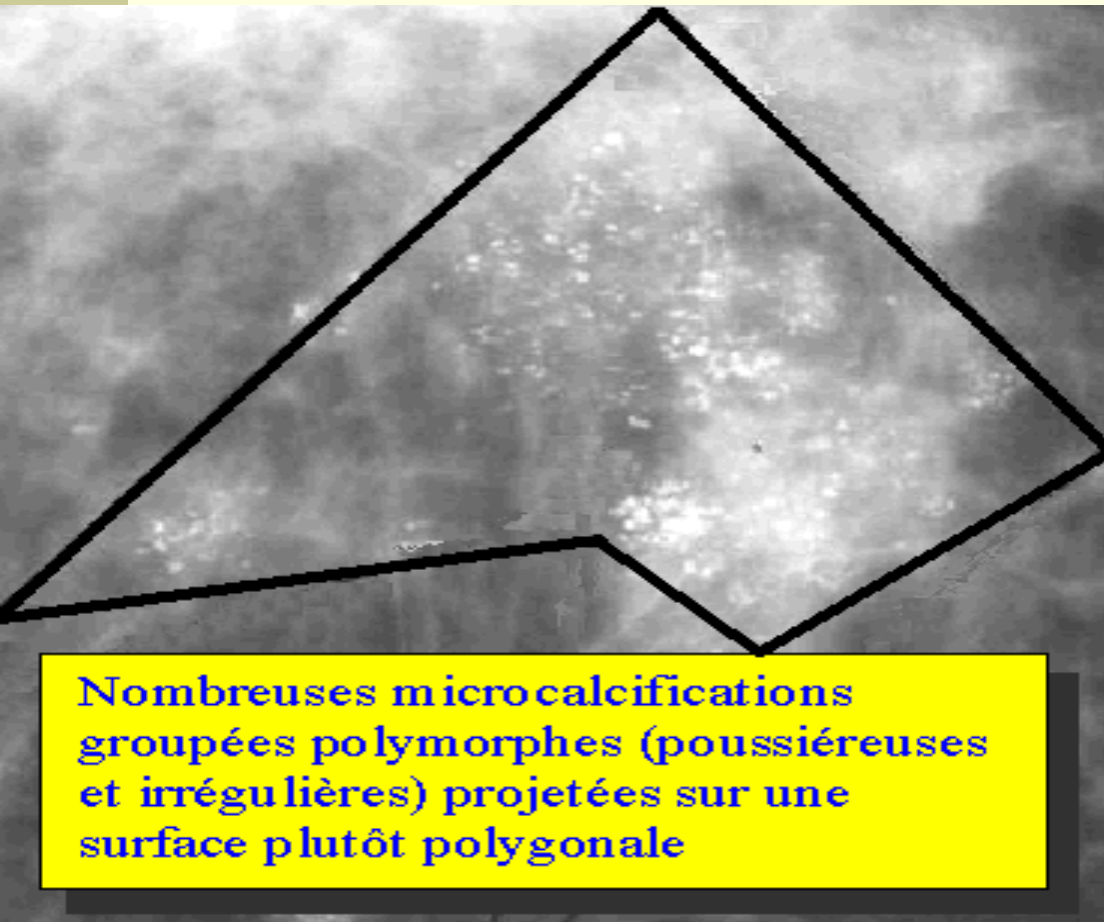
Risque de cancer estimé à 36 %.

Type 4 : micro calcifications irrégulières

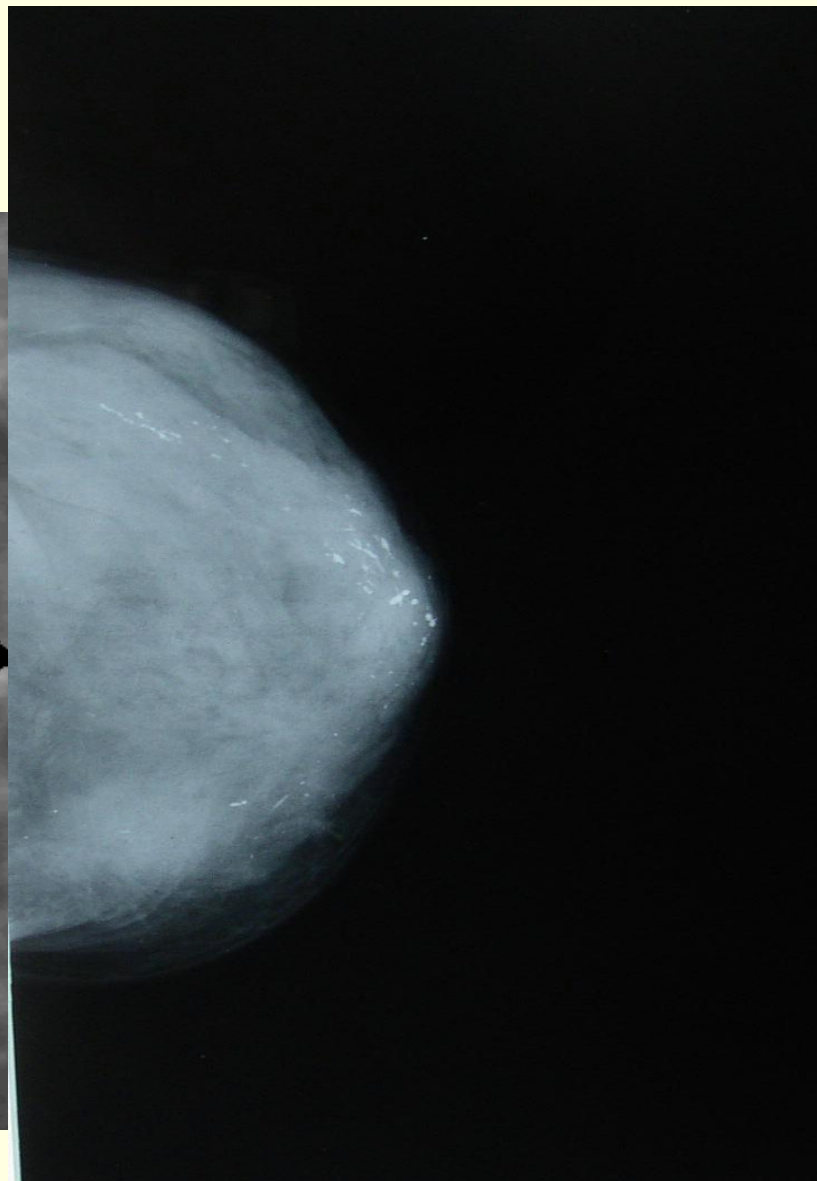
Risque de cancer estimé à 56 %.

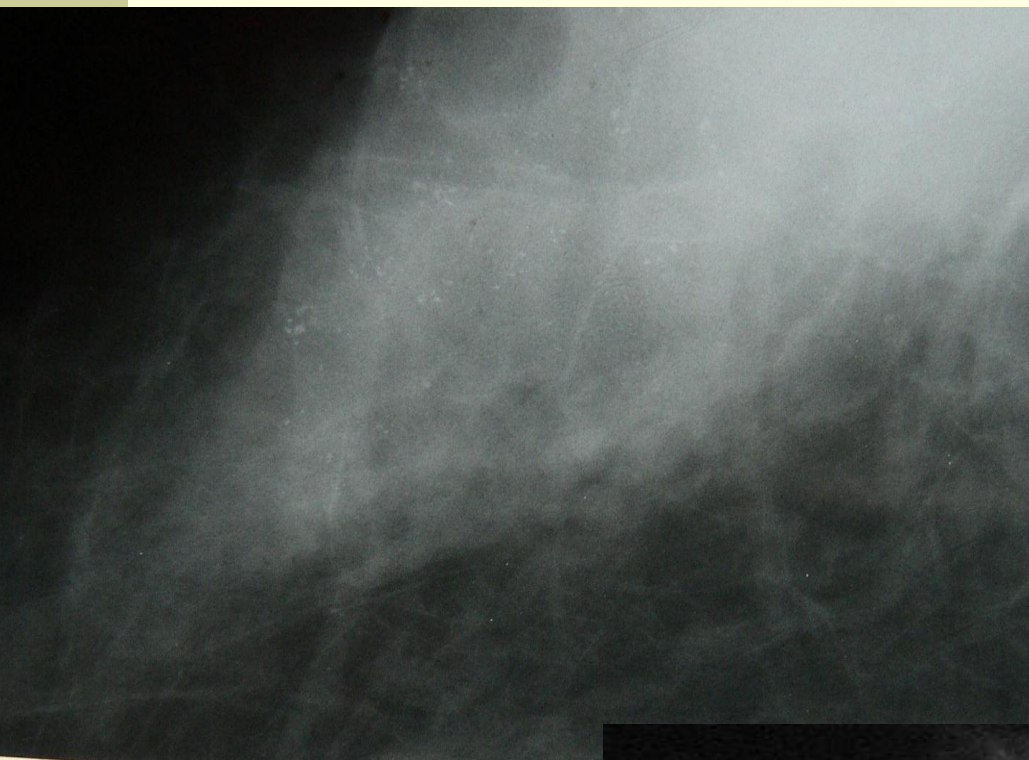
Type 5 : micro calcifications vermiculaires ou branchées.

Risque de carcinome estimé à 91 %.



Nombreuses microcalcifications
groupées polymorphes (poussiéreuses
et irrégulières) projetées sur une
surface plutôt polygonale





Plus de 30 microcalcifications de type IV et V selon Legal disposées dans un foyer polyédrique

2 - L'échographie mammaire :

- examen complémentaire
- surtout si seins denses chez la femme jeune
- attention : ne peut étudier les microcalcifications

□ Étude lésion

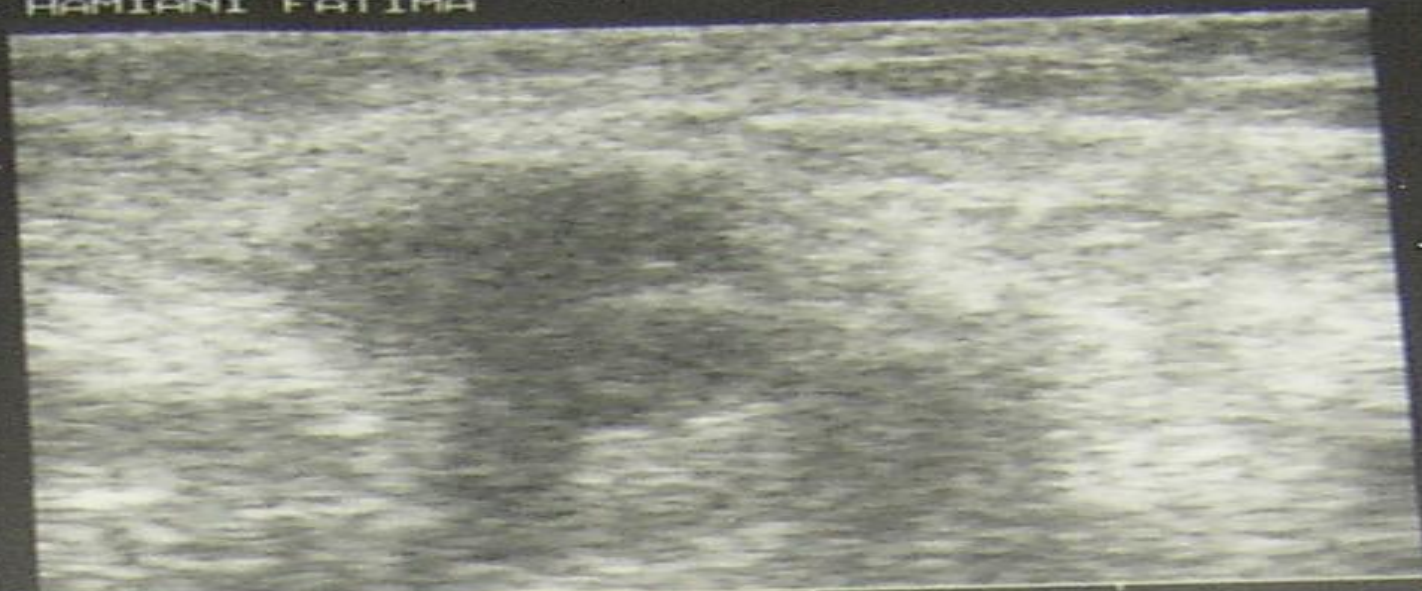
- Echogénicité de la lésion
- Homogénéité
- Forme et contours
- Grand axe perpendiculaire / parallèle à la peau
- En postérieur : cône d'ombre ou renforcement

- Le cancer du sein est
typiquement
 - une lésion hypoéchogène,
 - irrégulière,
 - à grand axe vertical
 - avec atténuation postérieure
(cône d'ombre).

CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL FJDD
ID: HAMIANI FATIMA

19/Set/2001
16:04

PROL
AXIL
OT



CINE

MEMOIRE

CLA1/L013
10.75.0MHz

CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL FJDD
ID: SITTEN AICHA

04/Jul/2002
11:42

TIS -
MI 0.4
P MAX
D 4 cm
PRC 17/2
PRF 6.7
CFM -
WF -
SD - mm
SS - mm
Cosa 0°
FC -
FR 18 fps

QII/JON
SD



BACK 0

ICONE



CINE

MEMOIRE

GENERAL

CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL FJDD
ID: SITTEN AICHA

04/Jul/2002
11:42

D1 21.3
mm

QII/JON
SD
LONG



BACK 0

Curseur sur le 1er point - ENTER pour le geler
Distance D

4 - L'IRM su sein :

- si mamographie et échographie sont insuffisants pour le diagnostic
- indications particulières
- grande valeur prédictive négative

— 5 - autres: intérêt diagnostique non

Échographie doppler - couleur,

TDM..

II- examens anatomopathologiques

a - examen histologique



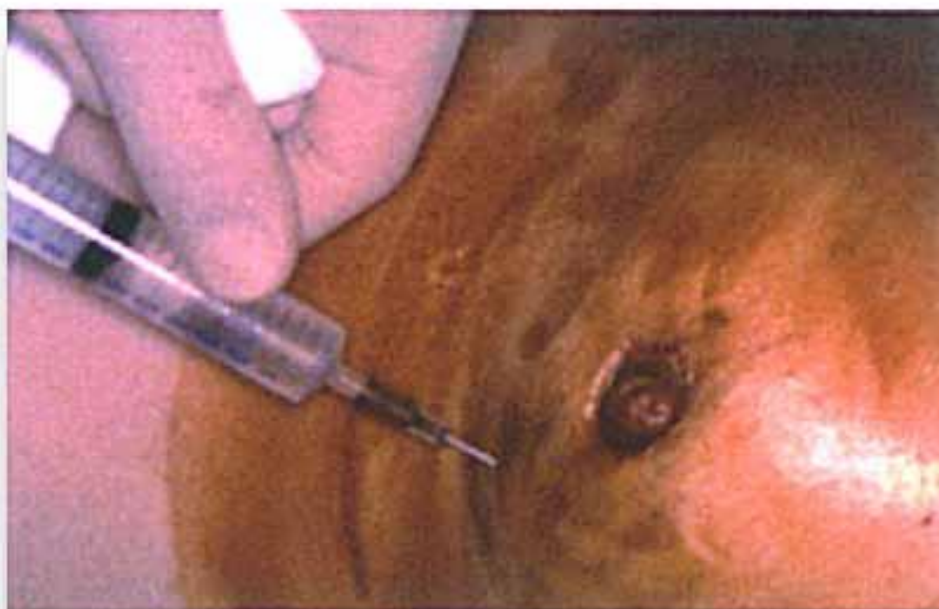
- * biopsie au tru-cut: microbiopsie +++
 - tumeur palpable ou echo guidée

Intérêt : ++++

- * Type histologique de la tumeur
- * Caractère infiltrant ou non de la tumeur
- * Le grade histologique de la tumeur
- * La recherche des récepteurs

b) Examen cytologique: Cytoponction

- Nodule
- adénopathie axillaire ou sus claviculaire palpable.
- liquide d'écoulement mamelonnaire
- Grattage cutanée si mie paget
- Ponction à l'aiguille fine



- Mais attention
- Renseigne sur présence ou non cellules malignes
- Cytoponction n'a de valeur que si positive
- Une cytologie négative n'élimine pas dg cancer
- *Toujours la confronter aux examens clinique et radiologique*
- *Si concordance □ diagnostic 99%*
 - *Peu de place actuellement*
 - *Intérêt examen histologique*

c) autres

\$ macrobiopsie : sous mammographie

- microcalcifications

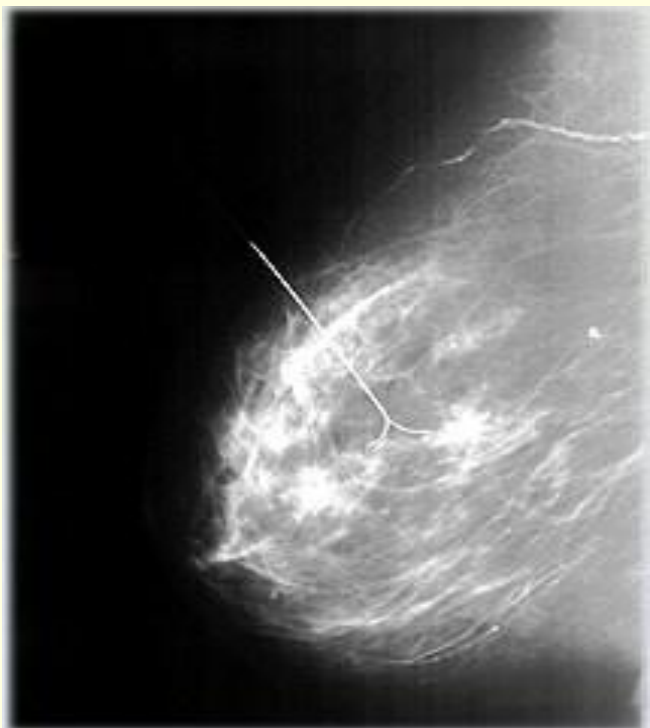
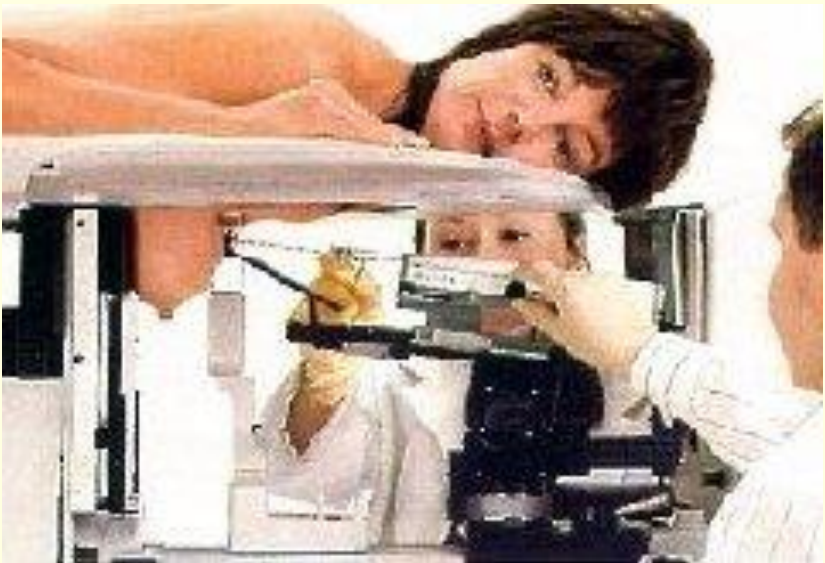
\$ Examen extemporané

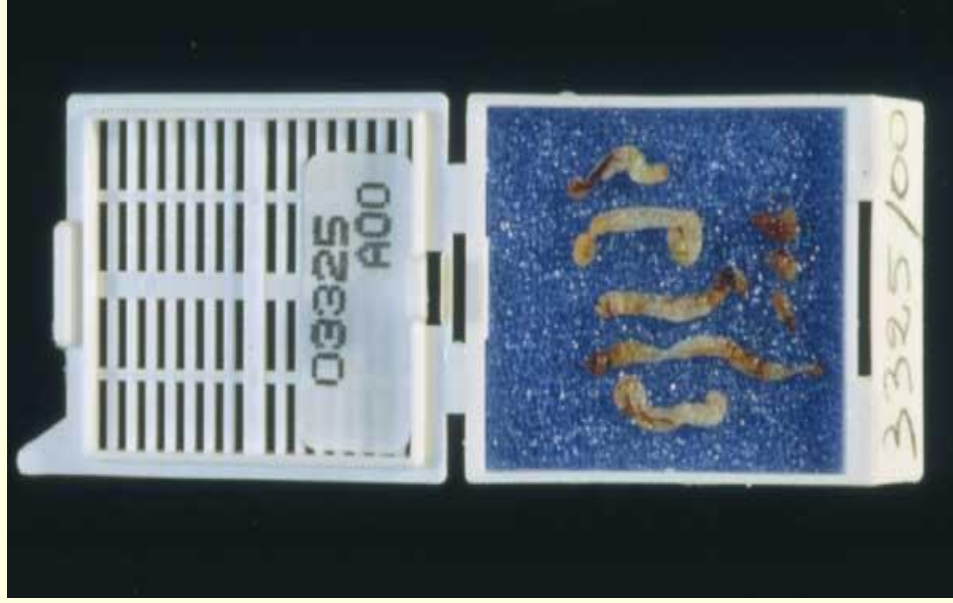
- si discordance clinique radio

\$ parfois sur pièce

- tumorectomie, pyramidectomie,
- repérage radiologique échographique ou mammographique (tumeur non palpables et microcalcifications)







III- bilan extension

- Radiographie du poumon +++++
 - Échographie hépatique +++++
 - Scintigraphie osseuse +++
 - pet scanner
 - Autres examens SI signes d'appel :
 - * TDM cérébrale
 - * radio standards des os
- ...etc.

IV - autres

- * marqueurs tumoraux

- Aucun intérêt diagnostique.
- surveillance post thérapeutique

- * CA 15-3 +++++

VI - CLASSIFICATIONS

A - Classification TNM :

adoptée par l'UICC : +++.

T - Taille de la tumeur :

T x : Détermination de la tumeur primitive est impossible.

T 0 : Pas de signe de tumeur.

T is : Carcinome in situ :

(CLIS, CCIS , Maladie de Paget sans tumeur palpable).

T 1 : Tumeur $\leq$ 2 cm dans son grand axe :

T1mi : microinvasion $\leq$ 1mm

T1a : $0,1\text{cm} < T \leq 0,5 \text{ cm}$

T1b : $T > 0,5 \text{ cm}$ et $\leq 1 \text{ cm}$

T1c : $T > 1 \text{ cm}$ et $\leq 2 \text{ cm}$.

T 2 : Tumeur $> 2 \text{ cm}$ et $\leq 5 \text{ cm}$.

T 3 : Tumeur $> 5 \text{ cm}$.

T 4 :

Quelle que soit sa taille avec extension

DIRECTE à la paroi thoracique ou à la
peau (ulcération, peau d'orange, nodule cutané
) :

T 4 a : Extension à la paroi thoracique

T 4 b : Extension à la peau

T 4 c : T 4 a (+) T4 b

T 4 d : Cancer inflammatoire.

N: Adenopäthies palpables

N x : Appréciation impossible de l'atteinte ganglionnaire.

N 0 : Absence de signes d'envahissement ganglionnaire régional.

N 1 : Ganglions axillaires homolatéraux
MOBILES

N 2 : Ganglions axillaires homolatéraux
FIXES entre eux ou à d'autres structures.

N 3 : Ganglions sous et sus claviculaires

M: métastases

M x : Détermination impossible de l'extension métastatique.

M 0 : Pas de métastases à distance.

M 1 : Métastases à distance

VII – DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL : +++++

A – Les tumeurs bénignes :

1 – Adénofibromes :

- Plus fréquentes.
- Femme JEUNE
- Clinique : caractéristiques bénignité
 - * Tumeur arrondie , ovoïde , mobile, ferme
 - * Sans adénopathies axillaires ou sus claviculaires.

- **Mammographie + échographie :**

Caractères de b nignit  .

- attention cancer m dullaire

- **Histologie :**

Prolif ration b nigne  
double composante  pith liale et
conjonctive.

2 - Tumeurs phyllodes :

- Clinique :

- * Tumeurs volumineuses , ovalaires à croissance RAPIDE , parfois polylobée, de consistance molle.

- Mammographie + échographie mammaire :

- * Aspect polycyclique , à contours réguliers et bien limités.

- risque de formes sarcomateuses +++

3 - Dystrophie fibrokystique du sein :

= Terrain d'hyperoestrogénie

- Clinique :

- * Mastodynies

- * Seins durs, avec des masses palpables, sensibles, consistance élastique et d'aspect kystique.

- Interêt radiologie et parfois histologie

- Si atypie: surveillance armée

B - Tuberculose mammaire :

- Localisation primaire ou secondaire

- ☐ Clinique :

- ☐ * Tumeur mal limitée.

- * abcès froid

- ☐ Radiologie : Aspect d'allure maligne.

- Histologie : +++++.

C - Abscès du sein :

Surtout en cas de cancer
inflammatoire d'où l'intérêt de
biopsie après drainage d'un
abcès

VIII – FORMES PARTICULIERES

A – Cancer du sein chez la femme enceinte ou allaitante :

- 1 à 3 % des cancers du sein.
- Diagnostic clinique : DIFFICILE.
- Diagnostic radiologique ?
- retard diagnostic ++++
- Problème de prise en charge.

B – Cancer du sein chez l'homme :

- **Très rare : 0,5 % des cancers du sein.**
- **Age : 60 – 65 ans.**
- **Clinique :**
Tumeur à caractères de malignité
- **Évolution :**
Plus rapide que chez la femme.
- **Pronostic : TRES SEVERE.**

IX- PRONOSTIC

A - Survie globale :

- * 50 % à 5 ans.
- * Survie à 5 ans des formes métastatiques < 15 %.
- * fonction de plusieurs paramètres dits facteurs pronostiques

B – Les facteurs pronostiques : +++++

1 - La taille tumorale :

- * petite taille ☐ moins de métastases
- * Associée au statut ganglionnaire, la taille tumorale permet de prédire de façon relativement précise la survie à 5 ans.
- * **< 0.5 avec N- ☐ 99% survie**
- * **< 0.5cm et plus de trois N+ ☐ 59%**

2 – Le statut ganglionnaire :

- * **facteur pronostique important**
- * **Nombre de ganglions envahis**
- * **Rupture capsulaire**
- * **Envahissement sus clavculaire**

3 – Le grading d’histopronostic : ++++

— = **Classification Scarff, Bloom et Richardson (SBR)**

Il prend en compte pour les

o la différenciation

o la morphologie nucléaire

o la richesse en mitoses

Chacun de ces éléments
est coté de 1 à 3

Classée de I , II et III.

Grade I : Bon pronostic ⇒ Peu évolutive (89%)

Grade III : Métastases rapides (54%)

4 – Les récepteurs hormonaux : +++

- Récepteurs à l'œstrogène (RO)
à la progestérone (RP)

- La présence de récepteurs hormonaux.

- * Facteur pronostique

- * facteur prédictif de réponse à hormonothérapie

5- facteur de prolifération : ki67

6 -La surexpression de HER2.

- 20% des malades**
- facteur prédictif de réponse à l'Herceptin (trastuzumab) anticorps monoclonal anti- HER2**

7- biologie moléculaire

8- AUTRES: TNM, age

Classes de tumeurs

Luminal A
RE /RP +
HER2 -,
Ki 67 <

Luminal B
RE /RP +
HER2 -,
Ki 67 >

HER2 +

Basal
Triple négatif
RE et RP -,
HER 2 -

X – LE TRAITEMENT : ++++

■ PRINCIPES

- cancer du sein maladie à potentiel général
- évolution locale ou générale
- Les traitements
 - traitement locale par chirurgie et ou radiothérapie
 - traitements généraux par hormonothérapie, chimiothérapie et/ou thérapeutique ciblée pour réduire le risque d'évolution métastatique

A - Les moyens thérapeutiques : +++

1) La chirurgie :

- vise à retirer la tumeur et les adénopathies axillaires envahies.
- Ses modalités dépendent du stade de la tumeur.
- On distingue :
 - Traitement radical
 - Traitement conservateur.

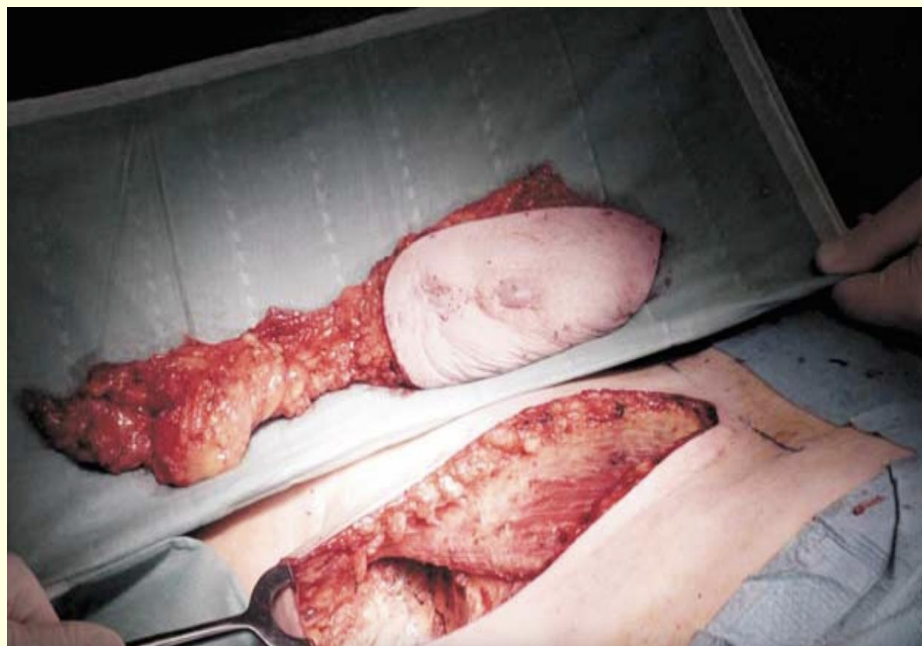
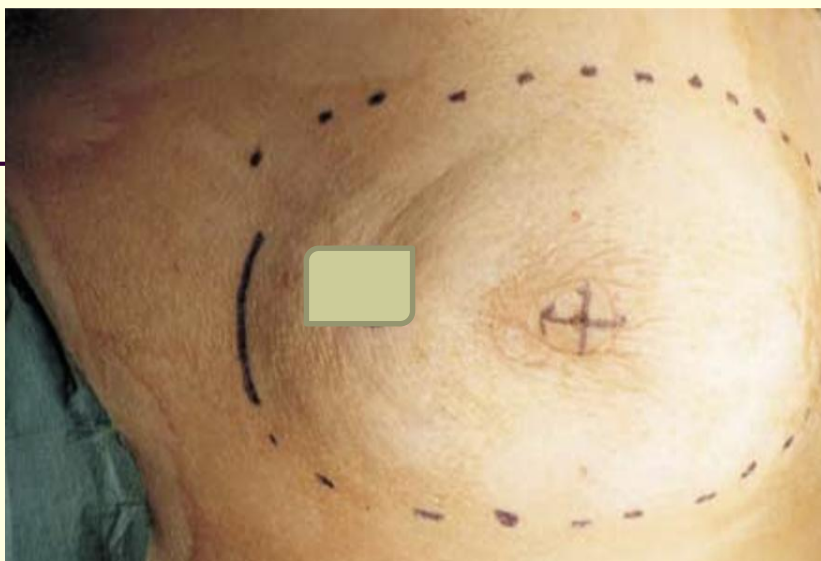
a - Traitement radical :

- **mastectomie** : exérèse de la totalité de la glande mammaire et de son revêtement cutané associé à un Curage axillaire homolatérale.

□ **Intervention de type Patey** : ++++

- **autres**

- **Mastectomie de propreté**
- **Intervention de type Halshted**



b - Traitement conservateur :

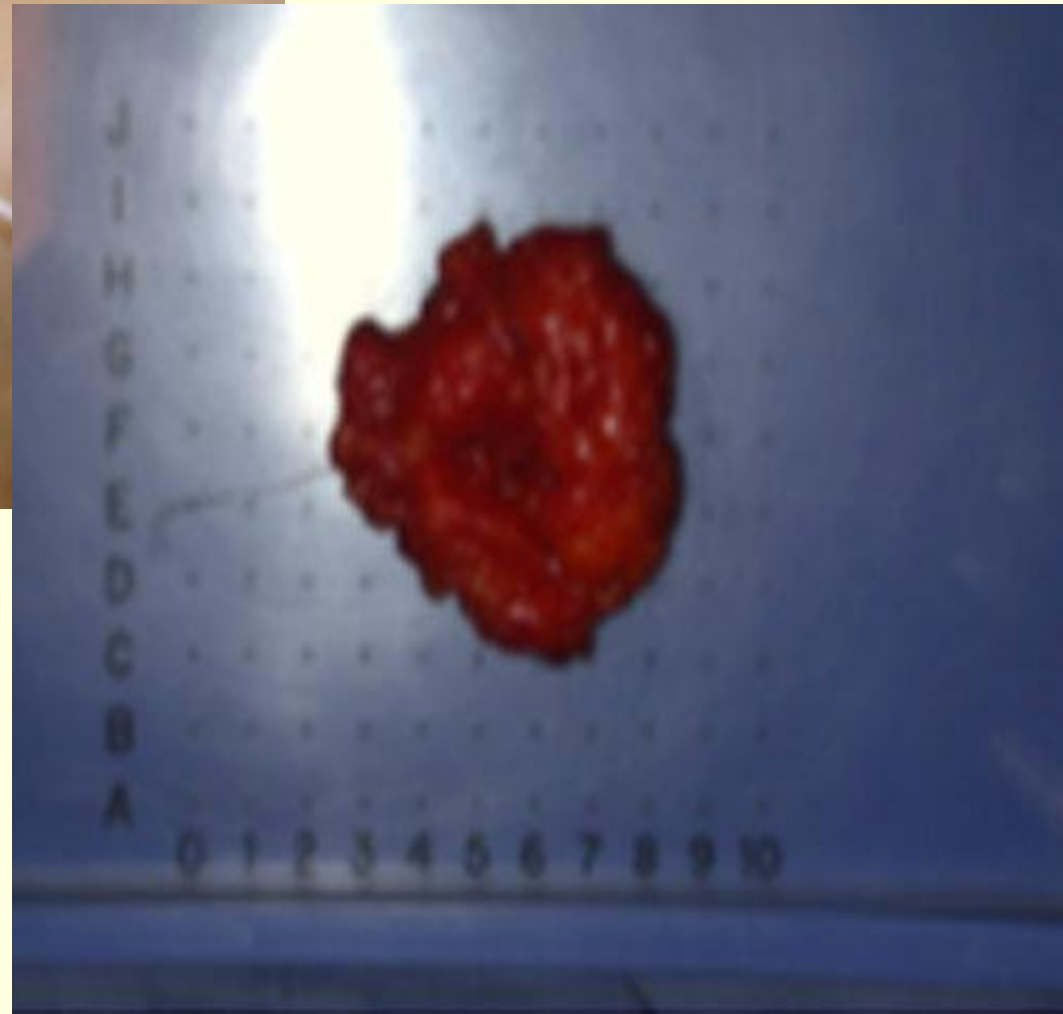
traitement conservateur de la glande mammaire tout en enlevant la tumeur avec des marges de sécurité

- * Tumorectomie LARGE**
- * Quadrantectomie**
- * Pyramidectomie**

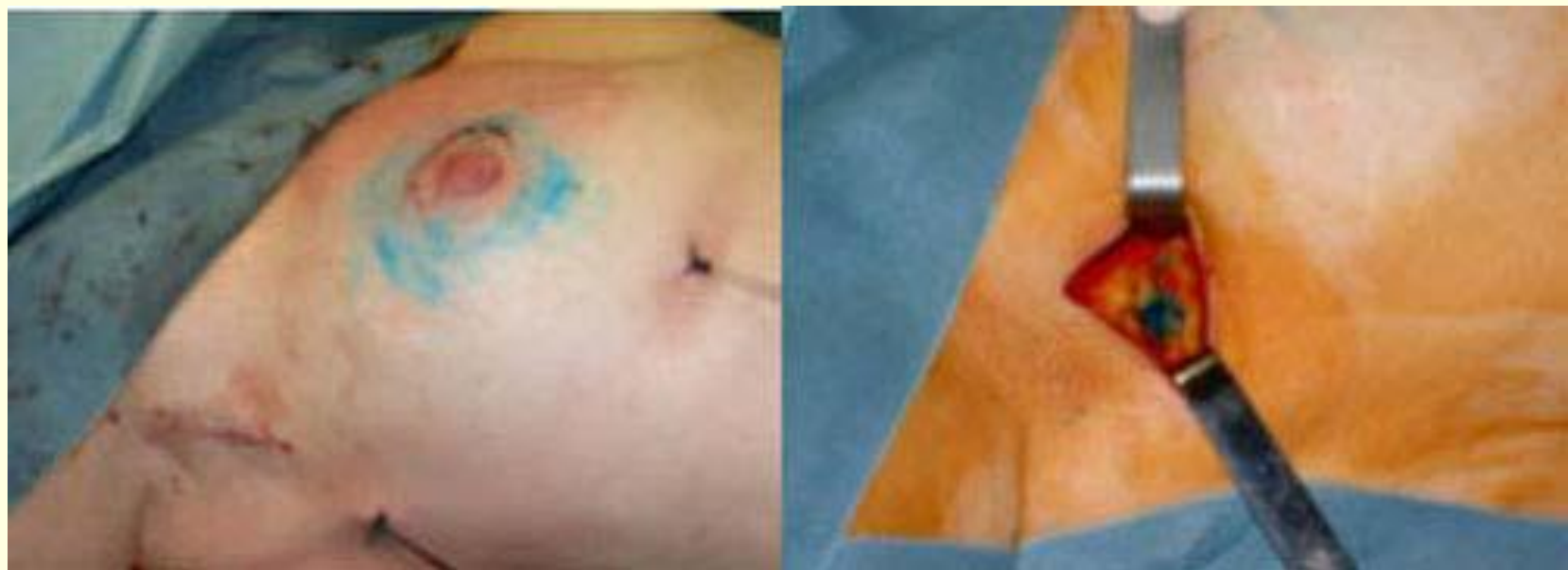
ASSOCIE A UN CURAGE AXILLAIRE







- Ganglion sentinelle
 - 1^{er} ganglion atteint
 - Deux méthodes
 - Colorimétriques
 - Isotopes
 - Si négatif : pas de curage
 - Éviter les complications du curage
 - Mais indications précises
 - Petite tumeur
 - Pas d'adénopathies clinique





2 - La radiothérapie :.

- **Intérêt** : Éviter les récurrences locales ++++ en complément avec la chirurgie
- **Radiothérapie externe** :
 - * sein ou paroi thoracique ou le lit tumoral
 - * Chaîne mammaire interne
 - * Creux axillaire
 - * Ganglions sus claviculaires
- **Par curiethérapie.**

3 -La chimiothérapie :

- Adjuvante ou néoadjuvante.

- Intérêt :

- * Éviter les métastases chez les patientes à RISQUE

- * Stériliser les micro foyers métastatiques.

- Plusieurs produits , plusieurs protocoles en fonction des écos :

CMF, FAC , FEC, taxanes ...etc.

4 -L'hormonothérapie :

Blocage de la fonction ovarienne :

⇒ Castration : + + + +

- Chirurgicale
- Radiothérapie
- Analogues de la LH-RH
- Anti-oestrogènes + + + +
- Inhibiteurs de l'aromatase + + + +

5- autres

***Herceptin*® (*trastuzumab*) :**

- Le trastuzumab, anticorps anti-HER2 chez les patientes dont la tumeur surexprime fortement HER2 (20% des patientes).
- diminution du risque de rechute de 50% à 3 ans

B – Indications thérapeutiques :

- **Fonction de plusieurs facteurs**
 - **Classification TNM**
 - **traitement conservateur ou non**
 - **Facteurs de prolifération**
 - **Envahissement axillaire.**
 - **Récépeteurs hormonaux**
 - **Surexpression HER2...**

- **CHIRURGIE**

- **Ttt CONSERVATEUR si possible**

⇒ **SI taille < 3cm**

⇒ Si pas de préjudice esthétique

⇒ **radiothérapie systématique**

- **Chimiothérapie en adjuvant**

⇒ si N+

⇒ si N – MAIS présence de facteurs de

- Age < 35 ans
- RE – et RP –
- SBR II ou III
- EV +
- HER2+++
- Taille >2 cm.....

- **Hormonothérapie** si récepteurs positifs
- **Herceptine si HER2 positifs**

- **Chimiothérapie NEOADJUVANTE**

- Tumeur localement avancés et inflammatoire T4
 - suivie de chirurgie conservatrice après
 - tumeur <2cm triple négative, herceptine ou luminal B....
- Discussion cas au cas et en multidisciplinaire

C – Traitement des formes particulières :

1 - Femme enceinte :

- **Chimiothérapie contreindiquée T1**
- **chirurgie non contre – indiqué**
- **Au premier trimestre :**
 - ⇒ **Interrompre la grossesse (= ITG)**
- **Au troisième trimestre :**
 - ⇒ **Attendre la maturité fœtale**
- **deuxième trimestre : discuter cas au cas:**
RCP

2- Traitement du carcinome in situ :

- **Il repose sur la chirurgie**
 - **conservateur avec berges $\geq$ 2mm**
 - **radical si lésions étendus**
- **En cas de traitement conservateur une radiothérapie complémentaire doit être réalisée**

3 - Sarcome mammaire :

→ **Mastectomie simple ++++**

4 - Lymphome malin :

→ **Chimiothérapie**

XII – SURVEILLANCE : +++++

- CLINIQUE +++++ :

- * 3 fois la première année**
- * puis chaque 6 mois**
- * une fois /an à partir de 5 ans.**

- Radiologique :

- * Une mammographie par an ; les 5 premières années.**
- * Puis une mammographie / 2 – 3 ans.**

- Biologique :

- * CA 15-3 / 6 mois.**



CONCLUSION